

INDICADO POR: *Cruzale*☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA

NS

EDILENE REJANE GONÇALVES DE LIMA

IDADE: 69 PESO: 74 ALTURA: 1,65 PROFISSÃO: *dona de casa*SINTOMAS: *Sonolência diurna, cansaço diurno, dor de cabeça*
*Reflexos*QUEIXAS: *irritabilidade / deficit memória*MEDICAMENTOS: *Rivan / Livala / alprazolam*MÉDICO: *Dr. André (Cardio) da Silva e Souza*

MARCAPASSO: () S (X) N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S (X) N

EXERCÍCIO FÍSICO: *5x semana / pilates, hidro academia*

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: 5 ALMOÇO: 5 LANCHE: 5 JANTAR: 19:00-19:30h

HORA QUE DORME: 22:30 HORA QUE ACORDA: 7:00h

COCHILHO (X) S () N DORME ACOMPANHADO: (X) S () N () EVENTUALMENTE

TEM FILHOS: (X) S () N / DORMEM NO QUARTO: () S (X) N PET NO QUARTO: () S (X) N

BEBIDA ALCOÓLICA: () S () X NA SEMANA (X) N *eventual*

FUMO: () S () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: *nasal* BANHEIRO/NOITE: 2X

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: *não* MALLAMPATI: *IV* IAH: 59,1cm SPO2: 74%PATOLOGIAS ASSOCIADAS: *esclerose / MMII leve moderada*CIRURGIAS: (S) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA *Rinoplastia 20anos*

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (N) CARDÍACA

(S) ORTOPÉDICA (N) NEUROLÓGICA () OUTROS:

POLISSONOGRAMA COM CPAP: () S () N SPO2 CI/CPAP: PRESSÃO NO EXAME:

18/06/25 *Análise de dados 4-10 cmH2O**masc. dream ulisp**Notada**Silicone (B)*24/06 P= 4-10 ($\Rightarrow$ Pmed. 8.5 / 9.9 perc) (Online)

25

IAH= 1.6 cmH2O

- não acorda mais/ ir ao

m. de uso: 8hr.

banheiro.

* Orientação sobre a

- menos sonolenta

máscara

grat.

01/07

P= 6-10

- Sonolência ↓

25

IAH= 1.6 cmH2O

- Melhora do cansaço.

m. de uso: 7h24'

- Banheiro 0x

fuga= 28.4

- Diminuiu muito dor de cabeça

15/02 Fez cirurgia de catarata

25

P = 9 cmHg

IAH = 1.1 ehw

M. de uso: 7h40'

fuga = 1.8 lpm.

font.

EDILENE RELANE GONÇALVES DE LIMA

PROFISSÃO:	ALTURA:	PESO:
MATERIAIS:		
AS:		
CAMENTOS:		
CO:		
CAPASSO: () S () N () COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S () N		
ERCIPIO FÍSICO:		
DIÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: ALMOÇO: LANCHE: JANTAR:		
ORA QUE DORME: HORA QUE ACORDA:		
OCHILLO: () S () N DORME ACOMPANHADO: () S () N () EVENTUALMENTE		
TEM FILHOS: () S () N DORMEM NO QUARTO: () S () N () PET NO QUARTO: () S () N		
BEBIDA ALCOÓLICA: () S () N () X NA SEMANA () N () NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:		
FUMO: () S () MACOIA () NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:		
TIPO DE RESPIRAÇÃO:		
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL:		
OVERLAP: MALLAMPATI: IAH: SPO2:		
CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:		
BANHEIRONCITE:		
PATOLOGIAS ASSOCIADAS:		
CIRURGIAS: () NASAL () AMIGDALECTOMIA		
HIPERTENSÃO DA ORELHA:		
COMORBIDADE: () RESPIRATÓRIA () ENDÓCRINA () CARDÍACA		
() ORTODONTIA () NEUROLÓGICA () OUTROS:		
POLISOMNOGRAFIA COM CPAP: () S () N () SPO2 CPAP: PRESSÃO NO EXAME:		

Nome: EDILANE REJANE GONÇALVES DE LIMA

Data de Nascimento: 20-9-1955

IMC: 26,45

Sexo: Feminino

Data do exame: 01-11-2024

Peso: 72 kg

Altura: 1,65 m

Médico: DR. PEDRO HENRIQUE PONTES

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 01-11-2024, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 495,5 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 60,5 e 109,5 minutos. O tempo total de sono foi de 369,5 min, eficiência de 74,6% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 1,6%; estágio N2: 71,7%; estágio N3: 5,0%; sono REM: 21,7%. O índice de despertares foi de 35,9/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 59,1/hora, sendo 20 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 174 hipopnéias. A SpO2 média foi de 90% e a mínima de 71%, permanecendo 27,4% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 62 - 97 bpm e NREM de 62 - 95 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (9), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do estágio N3 do sono NREM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 59,1/hora; -
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=71%);
5. latência para o sono aumentada;
6. aumento do número de despertares breves;
7. registro de ronco durante o sono.

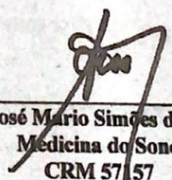
Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono e dessaturação de graus acentuados.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57.57